Schwerpunktpraxis

Gastroenterologie
an der Marktstätte

Per Fredrik Barlinn, Gastroenterologe, Marktstätte 7, 78462 Konstanz

Herrn
Dr. Muster

Gastroenterologie
Hepatologie - Proktologie

Per Fredrik Barlinn
Facharzt für Innere Medizin
und Gastroenterologie
Marktstätte 7
78462 Konstanz
Tel. 07531-26066
Fax.07531-16923
E-Mail: info@gastroenterologie-konstanz.de
www.gastroenterologie-konstanz.de

Konstanz, 26. März 2008

Lieber,

vielen Dank für die freundliche Überweisung von Herrn **Test**; geb. am 01.01.1900, der sich am 07.02.2008 bei mir vorstellte.

Anamnese:
Seit mindestens 1994 dokumentierte Hb-Werte zwischen 12 und 14 g/dl.
1994,2003,2004 und 2006 Koloskopien jeweils oB
8/2007 ÖGD oB
U-Status vor Jahren oB, war auch bei Urologen. Seit Jahren leicht erhöhte Kreatininwerte.
Anamnestisch auch schon nephrologische Vorstellung.
Fühlt sich seit Jahren müde, zuletzt progredient.
Medikamentenanamnese: ASS 100, Amlodipin, Ramipril, Metoprolol, Xipamid, Simva.
Bekannte KHK, Zn Stenting 2006.
Vit.B12 + Ferritin ok
Unter Vit-B12-Substitution keine Besserung
Keine Exposition mit Chemikalien.

Diagnose:

- Makrozytäre, normochrome Anämie.
- Kein Hinweis für chronische Blutungsanämie.
- Bekannte KHK (Zn Stenting)
- Chronische Niereninsuffizienz im Stadium der kompensierten Retention.

Zusammenfassung:

1) Eine potentielle **Blutungsquelle** als Anämieursache wurde bereits mehrfach endoskopisch (oberer und unterer GI-Trakt) ausgeschlossen. Dagegen spricht auch eine makrozytäre, normochrome Anämie. Zudem Ferritin im Normbereich. Eine mittlere GI-Blutung (Dünndarm) halte ich somit für äußerst unwahrscheinlich.
2) Das erhöhte MCV kann ein Hinweis für einen **Vit.-B12-Mangel** sein. Spiegel allerdings im Normbereich. Ein Therapieversuch mit Vit.-B12-Sobstitution ergab keinen Hb-Anstieg.

3) Gegen eine **renale Anämie** spricht das nur gering erhöhte Kreatinin. Eine nephtologische Vorstellung war laut Patient bereits erfolgt (Kreatinin-Clearance ?).
4) DD käme noch eine hämatopoetische Störung infrage. Ergänzend wäre die Bestimmung der Retikulozyten indiziert.
5) Aufgrund der leicht erhöhten BKS und der leichten Kreatininerhöhung sollte auch ein Plasmozytom ausgeschlossen werden (Immunelektrophorese, Sammelurin auf Eiweiss und Bence-Jones-Protein im Urin).
6) Der langjährige weitestgehend konstante klinische und laborchemische Verlauf kann auch Hinweis für eine Erkrankung des rheumatischen Formenkreises sein (Rheumafaktor, ANA usw.).

Zusammenfassend aus meines Sicht keine weitere Diagnostik im gastroenterologischen Fachgebiet indiziert.
Der bereits sehr lange Verlauf (dokumentiert seit 1994, siehe Kopie) spricht gegen eine progrediente/ tumoröse Erkrankung.
Ggf. ergänzende hämatologische und rheumatologische Vorstellung sinnvoll.

Mit freundlichen Grüssen

Per Fredrik Barlinn
Facharzt für Innere Medizin
und Gastroenterologie